

위암 진단 첫 30일

내시경 절제 · 수술 · 항암 순서 이해

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 03

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

조기위암은 내시경으로, 진행위암은 수술과 항암으로 — 병기가 길을 나눕니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Gastric Cancer, Version 4.2026 외 국내 자료 (본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

지금 내 상황	먼저 펼 곳
방금 진단을 들었고 머리가 하얗다	1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」
몸에 이상 신호가 있다	「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)
다음 주에 진료가 잡혀 있다	해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」
검사 결과지를 받았다	PART 1의 병리·검사·병기 장
돈·보험·회사가 걱정이다	PART 5 「돈 · 서류 · 제도」
마음이 무너질 것 같다	PART 4 「마음 돌보기」
가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다	PART 4 「보호자에게」

각 장의 구성은 같습니다.

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **⚠ 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 조기위암과 진행위암

30초 요약

- **조기위암**은 암이 위 점막·점막하층까지만 있는 경우로, 조건이 맞으면 **내시경 절제(ESD)**로 치료할 수 있습니다.
- **진행위암**은 근육층 이상으로 들어간 경우로, **수술이 중심**이며 병기에 따라 항암을 더합니다.
- 한국은 위암 진료 경험이 세계적으로 많은 나라입니다. 국내 진료 지침과 국제 지침(NCCN)이 일부 다르며, **둘 다 근거가 있는 전략**입니다.

결과지에 적힌 말	뜻	볼 곳
선종(저도·고도이형성)	전암병변. 내시경 절제가 흔함	담당의 확인(절제 후 암으로 나올 수 있음)
선암(분화형: 고·중분화)	가장 흔한 위암	이 책 전체
미분화형, 반지세포암	내시경 절제 기준이 더 엄격	4·6장
신경내분비종양, GIST, 림프종	위에 생기지만 다른 병	별도 상담

첫 30일의 지도

순서	할 일	시기
①	조직검사·조직형 확인	Day 0-3
②	복부 CT·내시경 초음파 등 병기 검사	Day 3-14

순서	할 일	시기
③	헬리코박터 검사 결과 확인	첫 진료
④	내시경 절제 vs 수술 vs 항암 먼저 결정	Day 7-21
⑤	치료·식사 준비	Day 14-30

오늘 물어볼 질문

1. 제 암은 조기위암인가요, 진행위암인가요?
2. 내시경 절제가 가능한가요, 수술이 필요한가요?
3. 치료를 정하기 전에 어떤 검사가 더 필요한가요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자 — 바로 연락하거나 응급실로

- **피를 토하거나 검은 변(짜장 같은 변), 어지럼·실신**
- 심한 복통이 점점 심해지고 배가 딱딱해짐
- 음식·물을 계속 토함, 방귀·배변이 멈추고 배가 부풀어 오름(장폐색 가능성)
- **시술·수술 후:** 38°C 이상 발열 + 심해지는 복통, 상처 발적·고름, 흑변·토혈
- 식후 1~3시간 뒤 식은땀·떨림·어지럼(후기 덤핑 저혈당) → 바로 사탕·주스. 의식이 흐려지거나 삼키지 못하면 119, 반복되면 진료 때 상의
- 항암 중 38°C 이상 발열(해열제보다 먼저 연락), 하루 4~6회 이상 설사, 손발이 붉게 붓고 벗겨짐
- 면역치료 중·후(몇 달 뒤에도) 심한 설사·혈변, 숨참, 심한 피로·어지럼, 눈·피부 노래짐
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 토혈·흑변은 종양이나 시술 부위 출혈일 수 있습니다.
2. 점점 심해지는 복통과 딱딱한 배는 천공 가능성이 있습니다.
3. 반복 구토·배변 정지는 위출구나 장이 막힌 신호일 수 있습니다.
4. 수술 후 발열·복통은 연결 부위 누출이나 감염 가능성이 있습니다.
5. 후기 덤핑 저혈당은 식사 방법 조절로 줄일 수 있습니다.
6. 항암 중 발열·심한 설사·손발 피부 변화는 연락 기준입니다. 먹는 항암제를 빠뜨렸을 때 두 배로 먹지 말고 문의하세요.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 조직검사 결과 받기 ② 위암 진료팀(소화기내과·위장관외과) 예약 ③ 복용 약(특히 혈액을 묽게 하는 약) 정리.

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 조직검사 결과지 — 선종인지 암인지, 분화도
- ☐ 위암 진료팀 예약(내시경 절제와 수술이 모두 가능한 병원이면 편리)
- ☐ 혈액을 묽게 하는 약(아스피린·항응고제 등) 복용 여부 기록 — 내시경 시술 전 중단 여부를 의료진이 정합니다

이번 주 할 일

- ☐ 복부·골반 CT, 필요 시 내시경 초음파·PET/CT 일정
- ☐ 헬리코박터 검사 결과와 제균 계획 확인
- ☐ 가족력(위암, 대장암 등) 정리 — 젊은 나이에 진단됐거나 가족력이 강하면 유전상담 문의
- ☐ 산정특례 신청(확진일로부터 30일 이내, 병원 원무과 대행이 많음)
- ☐ 식사량·체중 기록 시작

오늘 물어볼 질문

1. 조직검사 결과에서 분화도와 조직형은 무엇인가요?
2. 병기 검사는 무엇을, 언제 하나요?
3. 헬리코박터 검사 결과는 어떻고, 제균이 필요한가요?

4장. 병리·검사·병기

30초 요약: 먼저 볼 것은 **침윤 깊이(점막/점막하/근육층 이상) · 분화도 · 크기 · 궤양 · 림프관/혈관 침범 · 림프절**입니다.

검사	목적	기억할 점
위내시경·조직검사	진단, 위치·크기	선종도 절제 후 암으로 나올 수 있음
복부·골반 CT	림프절·간·복막 전이	기본
내시경 초음파	침윤 깊이	일부에서
PET/CT	원격전이	종류에 따라 잘 보이지 않을 수 있어 모두에게 하지는 않음
진단 복강경 + 복강 세척 세포검사	복막 전이 확인	진행위암 일부. 결과에 따라 치료 순서가 바뀜

병기	쉬운 뜻	흔한 치료 축
1기	점막·점막하(림프절 1~2개 포함) 또는 근육층까지(림프절 없음)	내시경 절제 또는 수술. ※ "조기위암"과 "1기"는 같은 말이 아님
2~3기	근육층 이상, 림프절 전이	수술(D2 림프절 절제) + 항암

병기	쉬운 뜻	흔한 치료 축
4기	원격전이(간·복막·먼 림프절 등)	바이오마커 기반 전신치료 ± 증상 완화 치료

- 위벽 안쪽으로 넓게 퍼지는 형태(미만형, 보우만 4형)는 내시경 조직검사에서 암세포가 잘 나오지 않을 수 있습니다. 영상·내시경 소견이 강하게 의심되면 조직검사를 다시 하거나 여러 소견을 함께 보고 치료를 정하기도 합니다. '조직검사 음성'이 무슨 뜻인지 담당의에게 확인하세요.

병리보고서 단어장

표현	뜻	왜 중요할까
tubular adenocarcinoma, well/moderately differentiated	분화형 선암	내시경 절제 기준이 상대적으로 넓음
poorly cohesive / signet ring cell	미분화형(반지세포)	기준이 엄격
depth: M / SM1 / SM2	점막 / 얇은 점막하 / 깊은 점막하	근치 판정
lymphatic/venous invasion	림프관·혈관 침범	추가 수술 필요성
margin	절제면	남은 암 여부
LN 2/35	검사한 35개 중 2개 전이	병기·항암 결정
ypT...	수술 전 항암 후 병기	치료 반응 정도가 함께 적힘

5장. 바이오마커와 헬리코박터

30초 요약

- **MSI/MMR**은 국제 지침에서 병기와 관계없이 진단 시 모든 환자에게 검사를 권고합니다(국내 시행·급여 확인 필요).
- **HER2·PD-L1(CPS)·Claudin 18.2**는 주로 진행·전이성에서 치료 선택에 씁니다.
- **헬리코박터**는 위암의 중요한 원인 중 하나입니다. 감염이 확인되면 제균 치료를 상의하고, 가족 검사도 담당의와 이야기하세요. 감염은 흔하며 **당신 잘못이 아닙니다**.

검사	의미	치료 범주(국내 허가·급여 확인 필요)
MSI-H / dMMR	DNA 수선 이상	면역치료 반응 가능성, 린치증후군 선별
HER2	IHC 3+ 또는 2+·ISH 양성	항암 + HER2 표적(대표 예: 트라스투주맵), 이후 HER2 ADC
PD-L1 CPS	면역치료 효과 예측(점수에 따라 다름)	항암 + 면역치료
Claudin 18.2	위암 세포 표면 단백질	항암 + Claudin 18.2 표적(대표 예: 졸베특시맵)

- HER2 2+는 ISH로 확정합니다. 생검 조직이 작으면 부위에 따라 결과가 다를 수 있습니다.
- PD-L1은 **점수와 검사 종류(항체명)**를 함께 적어 두세요.

헬리코박터 제균 실무

- 보통 1~2주 약을 먹습니다. 빠뜨리지 않는 것이 성공률을 높입니다. 흔한 부작용: 쓴맛, 설사, 메스꺼움.
- 제균 후 약 4주 이상 지나 성공 여부를 다시 검사합니다(시점은 병원 안내).
- **가족:** 부모·형제·자녀의 헬리코박터 검사와 위내시경 검진 필요성을 담당의와 상의하세요. 국가 위암 검진은 만 40세 이상 2년마다 받습니다. 2026년 6월 개정된 국가 위암검진 권고안은 **위내시경을 단독 1차 검사**로 권하고, 위장조영검사는 내시경이 어려운 경우가 아니면 권하지 않으며, **75세 이상**은 위내시경 검진을 일상적으로 권하지 않습니다(실제 검진 항목은 국민건강보험공단 확인).
- 젊은 나이(예: 40세 전) 진단, 가족 중 위암 여러 명, 미만형 위암 가족력이 있으면 유전상담을 문의합니다.

바이오마커 기록: MSI/MMR _ · **HER2** _ (ISH _) · **PD-L1 CPS** _ (검사 _) · **CLDN18.2** _ · 헬리코박터 ☐양성 ☐음성 → 제균 ☐예정 ☐완료 ☐재검 ____

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

6장. 조기위암: 내시경 절제(ESD)

30초 요약: 크기·분화도·궤양·침윤 깊이가 기준 안이면(대표적인 예: 2cm 이하, 분화형, 궤양 없는 점막암 — 세부 기준은 한국 진료 지침과 병원 판단) **ESD로 위를 지키며 치료**할 수 있습니다. 절제 후 **최종 병리**로 근치 여부를 판정하고, 기준을 벗어나면 **추가 수술**을 권할 수 있습니다.

- ESD 후 확인할 3가지: ☐ 최종 병리의 근치 판정 ☐ 다음 내시경 날짜 ☐ 헬리코박터 제균
- **추가 수술을 권유받는 것은 실패가 아니라** 떼어 낸 조직에서 림프절 전이 위험이 확인되었다는 정보입니다.

ESD 후 추가 수술을 권유받았다면

1. 기준을 벗어난 항목(깊이, 림프관 침범, 절제면 등)은 무엇인가요?
2. 수술할 때와 하지 않을 때의 위험을 제 경우로 설명해 주실 수 있나요?
3. 수술은 언제쯤, 어떤 범위(복강경 여부)로 하나요?

ESD 전후

- 시술 전: 혈액을 묽게 하는 약 중단 여부는 의료진 지시. 금식.
- 시술 후 1~2일 금식 후 물·미음부터. 1~2주 자극적 음식·술 피하기.
- 입원은 보통 2~3일 안팎입니다. 시술 자리 궤양이 아물도록 위산억제제를 몇 주 (대개 한 달 안팎) 먹습니다. 처방 기간은 병원 안내를 따르세요.
- ESD 뒤 지연 출혈은 시술 후 2주 안에도 생길 수 있습니다. **흑변·토혈·어지럼**이면 바로 연락하세요.

7장. 수술: 위절제와 D2 림프절 절제

30초 요약: 진행위암은 위의 일부 또는 전부와 주변 림프절을 함께 떼는 수술이 기본입니다. 이때 **D2 림프절 절제**가 한국·일본과 국제 지침(NCCN)이 원하는 표준 범위입니다. 조기위암은 범위를 줄인 수술(D1+, 기능보존 수술)을 하기도 합니다.

수술	내용
원위부(아전) 위절제	위의 아래쪽 2/3 정도
위 전절제	위 전체
유문보존·근위부 위절제	조기위암에서 기능 보존 목적
복강경·로봇	병기·병원에 따라 선택
복강경·로봇	병기·병원에 따라 선택. 로봇수술은 국내에서 건강보험이 적용되지 않아 본인 부담이 클 수 있음(비용은 원무과 확인, 2026.10 기준 확인 필요)

회복 달력(일반적 예시)

시기	식사	할 일
수술 후 1-3일	금식 → 물	걷기, 통증 조절
3-7일	미음·죽	소량씩 천천히, 퇴원 교육
2-4주	부드러운 밥	하루 5~6끼, 체중 기록
4-8주	점차 일반식	덤핑 일기, 복직 상의

연락할 때 이렇게 말하세요

"○월 ○일 위절제 수술받은 ○○○입니다. 어제부터 열이 38.3도이고 배가 점점 아픕니다." — 수술 날짜·수술명·증상·시작 시점을 한 문장으로.

8장. 수술 전후 항암: 한국과 국제 지침 나란히 보기

30초 요약: 2~3기 진행위암에서 **수술 후 보조항암**(한국·아시아 표준 축)과 **수술 전후(주변수술기) 항암**(서구 표준 축)은 모두 근거가 있는 전략입니다. 병원·병기·체력에 따라 정합니다.

비교	수술 먼저 + 보조항암	수술 전후 항암
주로 쓰는 곳	한국·일본 등	미국·유럽(NCCN)
순서	D2 수술 → 항암 6개월~1년	항암 몇 주기 → 수술 → 항암
대표 요법 예시	먹는 항암제 단독 또는 주사 +먹는 항암제 병용	여러 약을 묶은 병용요법(일부는 면역치료를 더하는 전략)
장점	정확한 병리 병기 후 결정	수술 전 종양을 줄이고 미세 전이 치료

- 수술 전후 항암에 **면역치료를 더하는 전략**이 새 범주로 추가되었습니다(국내 허가·급여 확인 필요).
- MSI-H 위암은 항암 반응이 다를 수 있어 치료 순서를 따로 상의합니다.
- 수술 후 보조항암은 회복 상태를 보며 **대개 수술 후 8주 안에** 시작합니다. 국내에서는 먹는 항암제를 1년 먹는 방식과, 먹는 항암제 + 주사를 3주 간격으로 6개월 하는 방식이 혼합니다(내 일정은 담당의 확인).

9장. 진행·전이성 위암

30초 요약: 1차 치료는 **항암을 바탕으로 바이오마커에 따라 HER2 표적·면역치료·Claudin 18.2 표적**을 더합니다. **출혈·통증·음식이 내려가지 않을 때는 완화 방사선·내시경 스텐트·시술**을 함께 씁니다.

상황	범주(국내 허가·급여 확인 필요)
HER2 양성	항암 + HER2 표적(대표 예: 트라스투주맙, ± 면역치료) → 이후 HER2 ADC(대표 예: 트라스투주맙 데록스테칸) 등
HER2 음성, PD-L1 양성	항암 + 면역치료(대표 예: 니볼루맙·팼브롤리주맙)
Claudin 18.2 양성 (HER2 음성)	항암 + Claudin 18.2 표적(대표 예: 졸베톡시맙)
MSI-H	면역치료 중심
증상 완화	방사선(출혈·통증), 스텐트(통과 장애), 영양 지원

국내 급여 참고(2026년 6월 국내 공공 암정보 기준, 바뀔 수 있음):
면역치료는 약마다 정해진 PD-L1 기준을 넘을 때 급여가 되고, Claudin 18.2 표적치료제는 아직 비급여입니다. HER2 양성에서 HER2 ADC는 3차 치료부터 급여가 됩니다. 처방 전에 비용을 원무과에 확인하세요.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.
- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서 확인합니다.
- 완화医료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서**: 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).

- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 드립니다.

2차 소견과 병원 선택

30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때
- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 위암 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요?
아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)
- ☐ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- ☐ 영상 CD + 판독지
- ☐ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- ☐ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.
- 임상시험에 참여해도 언제든 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?

3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?

PART 3. 30일 실행 로드맵

Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 조직검사 결과 ☐ 진료팀 예약 ☐ 복용 약 정리 ☐ 연락처 저장 ☐ 산정특례 문의

Day 4-7 · 검사받기

- ☐ CT·내시경 초음파 ☐ 헬리코박터 결과 ☐ 바이오마커 의뢰 확인 ☐ 체중·식사 기록

Day 8-14 · 결정하기

- ☐ ESD / 수술 / 항암 먼저 결정 ☐ 수술 전후 항암 방식 설명 ☐ 필요 시 2차 소견

Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 시술·수술 전 검사 ☐ 영양 상담 ☐ 간병·휴직 계획 ☐ 제균 치료 시작(해당 시)

Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 치료 시작 ☐ 퇴원 후 식사 단계표 ☐ 증상 일지 ☐ 보험 서류 접수
-

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

위절제 후 먹는 법

30초 요약: 위 수술 뒤에는 "한 번에 많이"가 아니라 **"조금씩 자주, 천천히, 잘 씹어서"**가 원칙입니다. 체중이 계속 줄거나 식사량이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청하세요. 위 전절제 후에는 비타민 B12 보충이 오래 필요할 수 있습니다.

- **퇴원 후 첫 2주 하루 예시:** 아침 죽 반 공기 + 달걀찜 / 오전 간식 두유 반 컵 / 점심 진밥 반 공기 + 생선조림 / 오후 간식 바나나 반 개 / 저녁 진밥 반 공기 + 두부 / 밤 요거트 소량(유당 불편 시 조절).
- **초기 덤핑**(식후 30분 안 두근거림·식은땀·설사): 단 음료·국물을 식사와 함께 많이 먹지 않기, 식후 잠시 눕기.
- **후기 덤핑**(식후 1~3시간 저혈당): 단순당을 줄이고 단백질·복합탄수화물 함께.

8주 식사 로드맵

주	형태	하루 끼니	팁
1-2	죽·부드러운 반찬	6끼	한 끼 20~30분, 30번 씹기
3-4	진밥	5~6끼	단백질 반찬 매 끼
5-8	일반 밥(소량)	5끼	외식은 반 공기부터, 국물은 따로
명절·외식	기름진 음식·떡 조심	—	천천히, 조금씩

덤핑 알기

날짜	먹은 것	증상(시간)	메모
----	------	--------	----

장기 영양

- **비타민 B12:** 위 전절제 후 장기간 보충(주사·약)이 필요한 경우가 많습니다. 일정은 의료진과 정합니다.
- **철·칼슘·비타민 D:** 빈혈·골다공증 검사를 정기적으로 상의합니다.
- 담석·유당불내증이 생길 수 있습니다.

추적

- 수술 후 정기 CT·내시경·혈액검사(간격은 병기에 따라). ESD 후에는 정해진 간격의 내시경이 핵심입니다.
- 흔한 예로 처음 3년은 3~6개월마다, 그 뒤 5년째까지는 6개월~1년마다 진료를 봅니다. 재발은 대부분 5년 안에 생기므로 **적어도 5년**은 추적을 이어 가세요 (간격은 병원마다 다름).
- 남은 위에 새 암이 생길 수 있어 내시경 추적이 중요합니다.

치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
메스꺼움·구토	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰 (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커	하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음
피로	짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청	숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
입안 혈음	부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금· 베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기	통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반
변비	수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께	3일 이상 변이 없고 복통· 구토, 배가 부풀
설사	수분·전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사
불면	일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용 (지시대로)	2주 이상 계속, 불안·우울 동반
탈모	순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단	— (대개 치료 후 다시 자람)
피부 발진· 건조	순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단	물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막 (입·눈) 침범
손발 저림	찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의	단추·젓가락·걸기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기
식욕 저하· 체중 감소	먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충 음료	한 달 5% 이상 체중 감소, 평소의 절반 이하로 1주 이상

열이 나면: 항암 중 38°C 이상(병원 기준에 따라 37.8°C 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

날짜 점수(0~10) 가장 힘든 것(☐ 걱정 ☐ 잠 ☐ 통증 ☐ 돈 ☐ 가족 ☐ 일 ☐ 기타)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 견디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면 국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

불안이 물려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.

3. **내 몫 나누기:** 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기:** 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

"내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 듣고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

보호자에게

보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당:** 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당:** 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구:** 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.
- **결정은 환자가:** 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

피하면 좋은 말과 바뀌 쓸 말

피하면 좋은 말	바뀌 쓸 말
"긍정적으로 생각해야 나아"	"힘든 마음 그대로 말해도 돼"
"왜 검진을 안 받았어"	"지금부터 같이 챙기자"
"○○ 먹으면 낫는데"	"새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자"
"너보다 더 힘든 사람도 있어"	"네가 힘든 건 힘든 거야"

아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로**: "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 곳이 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 윗은 병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법, 2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원 사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

직장과 일상

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

먹는 것과 움직이는 것

식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.
- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋은 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.

- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
 - 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
 - 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
 - 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ **1544-9030**을 이용하세요.
-

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

항목	내용(2026.10 기준, 확인 필요)
대상	암으로 확진된 환자(위암 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인
혜택	건강보험 급여 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름
기간	적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사
신청 시한	확진일로부터 30일 이내 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용
방법	진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능

확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

제도	핵심	문의
본인부담상한제	1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외)	국민건강보험공단 1577-1000
재난적 의료비 지원	소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)	공단 지사·병원 사회사업팀
국가 암환자 의료비 지원	의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원	주소지 보건소
병원 사회사업팀 (의료사회복지사)	후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움	진료 병원 사회사업팀

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

3. 보험 청구 서류 체크리스트

민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

서류	어디서	메모
병리보고서(조직검사 결과지)	진단 병원 의무기록팀	바이오마커 결과 포함 여부
병리 슬라이드·파라핀 블록 대여	진단 병원 병리과	다른 병원 재판독·추가검사에 필요. 반납 기한 확인

서류	어디서	메모
영상 CD + 판독지	진단 병원 영상의학과· 의무기록팀	CT·MRI·PET 모두
혈액검사 결과	의무기록팀	최근 것
진료의뢰서(소견서)	담당 의사	상급종합병원 외래는 의뢰서가 있어야 건강보험 적용

위암 참고: 질병코드는 C16입니다. 선종이나 점막내암으로 진단명이 바뀌는
경우 보험 진단비 기준이 다를 수 있어 **최종 병리 후** 청구하세요.

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 조기위암인가요, 진행위암인가요? 2. 분화도·조직형은 무엇인가요? 3. 내시경 절제가 가능한가요? 4. 수술이라면 범위(아전·전절제)와 방법은요? 5. 수술 후 항암인가요, 수술 전후 항암인가요? 6. MSI·HER2·PD-L1·Claudin 18.2 결과는요? 7. 헬리코박터 제균이 필요한가요? 가족도 검사하나요? 8. 수술 후 식사는 어떻게 하나요? 9. 바로 연락해야 할 증상은 무엇인가요? 10. 임상시험이나 다학제 진료가 가능한가요?

내 위암 한 장 요약

항목	내 기록
조직형·분화도	_____
병기	임상 _ → 병리 _
위치·크기	_____
림프절	_ / _
바이오마커	MSI _ HER2 _ PD-L1 _ CLDN18.2 _
헬리코박터	☐ 양성 ☐ 음성 · 제균 _____
첫 치료	ESD / 수술(종류 _____) / 항암 먼저
산정특례	☐ 신청 ☐ 완료

오늘 꼭 물을 3가지: ① 내시경 절제가 가능한가요? ② 수술과 항암의 순서는? ③ 헬리코박터와 가족 검진은?

같은 진단, 다른 30일 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다.

55세 동훈 씨 — 조기위암 ESD 후 추가 수술 권유 "내시경으로 끝난 줄 알았는데." 최종 병리에서 림프관 침범이 보였다. 세 가지 질문지를 들고 다시 진료실에 갔고, 수술할 때와 하지 않을 때의 위험을 숫자 대신 그림으로 설명 들었다. "실패가 아니라 정보가 더해진 거라는 말에 마음이 정리됐어요."

61세 순자 씨 — 3기, 위 전절제 후 보조항암 체중이 한 달에 5kg 줄었다. 영양 상담에서 하루 6끼 식단표와 덤핑 일기를 받았고, B12 주사 일정도 생겼다. "먹는 게 치료라는 걸 알고 나니, 밥상이 숙제가 아니라 약이 됐어요."

42세 재민 씨 — 4기, HER2 양성, 자영업 가게와 치료를 같이 할 수 있을지가 가장 큰 걱정이었다. 사회사업팀에서 의료비 지원제도를 확인하고, 항암 주기에 맞춰 영업시간을 조정했다. "치료 목표를 듣고, 3개월 단위로 계획을 세우니 막막함이 줄었습니다."

용어사전

용어	쉬운 뜻
조기위암 / 진행위암	점막·점막하까지 / 근육층 이상 침범
ESD(내시경 점막하 박리술)	내시경으로 병변을 통째로 떼는 시술
근치 판정	내시경 절제로 치료가 충분한지 병리로 판단
D2 림프절 절제	위 주변 림프절을 정해진 범위까지 떼는 표준 수술

용어	쉬운 뜻
보조항암 / 주변수술기 항암	수술 후 항암 / 수술 전후 항암
덤핑증후군	위 수술 후 음식이 빨리 내려가 생기는 증상
헬리코박터 파일로리	위에 사는 세균. 위암 위험과 관련
MSI-H/dMMR	DNA 수선 이상. 면역치료 반응과 관련
Claudin 18.2	위암 세포 표면 단백질. 표적치료 대상
복강 세척 세포검사	배 안을 씻은 물에서 암세포를 찾는 검사

자주 묻는 질문 12

Q1. 조기위암인데 왜 CT를 찍나요? 림프절이나 다른 장기 전이가 없는지 확인해야 내시경 절제가 적절한지 판단할 수 있습니다.

Q2. ESD 후에 위가 정상으로 돌아오나요? 대부분 위 기능이 유지됩니다. 다만 남은 위에 새 암이 생길 수 있어 정기 내시경이 중요합니다.

Q3. 위를 다 떼면 어떻게 먹고 사나요? 식도와 소장을 연결해 음식이 지나가게 합니다. 처음 몇 달은 조금씩 자주 먹는 연습이 필요하고, 대부분 일상 식사로 돌아갑니다. 비타민 B12 보충은 오래 필요할 수 있습니다.

Q4. 헬리코박터를 제균하면 재발이 줄어드나요? 내시경 절제 후 제균은 남은 위에서 새 위암이 생길 위험을 줄인다는 근거가 있습니다.

Q5. 수술 후 체중이 계속 빠지는데 정상인가요? 수술 후 몇 달간 체중이 줄어드는 것은 흔합니다. 계속 빠지거나 한 달에 5% 이상 줄면 영양 상담을 요청하세요.

Q6. 보조항암을 꼭 해야 하나요? 2~3기에서는 재발 위험을 줄이는 근거가 있습니다. 체력·나이·병기에 따라 담당의와 상의하세요.

Q7. 먹는 항암제는 주사보다 약한가요? 약의 종류가 다를 뿐 효과가 약한 것은 아닙니다. 손발 피부 반응·설사 등 부작용을 관리하며 빠뜨리지 않고 먹는 것이

중요합니다.

Q8. 덩핑 때문에 단 걸 전혀 못 먹나요? 단순당을 한 번에 많이 먹지 않으면 대부분 괜찮습니다. 단백질과 함께 조금씩 드세요.

Q9. 술은 언제부터 마셔도 되나요? 위 수술 후에는 알코올이 빨리 흡수되어 적은 양에도 취하기 쉽습니다. 가능하면 피하고, 마신다면 담당의와 상의하세요.

Q10. 가족도 위내시경을 받아야 하나요? 만 40세 이상은 2년마다 국가 위암 검진 대상이며, 2026년 개정 권고안은 위내시경을 기본 검사로 권합니다. 가족력이 있으면 더 일찍, 더 자주 받을지 상의하세요.

Q11. 전이가 있으면 수술은 못 하나요? 대부분 전신치료가 중심이지만, 출혈·막힘 같은 증상에는 수술·스텐트·방사선이 쓰일 수 있습니다.

Q12. 위암은 유전되나요? 대부분은 유전과 무관하지만, 젊은 나이·가족 중 여러 명·미만형 위암 가족력이 있으면 유전성담을 받을 수 있습니다.

진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

30초 요약: 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

진료 전달

- ☐ 질문 3개를 우선순위로 적기(워크북 W2)
- ☐ 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩
- ☐ 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

진료실에서

1. 첫 문장으로 가장 중요한 것부터: "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."

2. 어려운 말이 나오면: "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"
3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 **먼저 의료진에게 양해를 구하세요.** 허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

검사 준비 카드

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
CT(조영)	몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)	조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성	촬영은 10~20분
MRI	금속 제거, 일부는 금식	심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능	30~60분

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
PET/CT	(FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내	당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유	주사 후 대기 포함 2~3시간
조직검사 (바늘)	금식 여부 확인	혈액을 묽게 하는 약(중단 여부는 의료진 지시), 알레르기	시술 후 관찰 수시간
내시경	금식, 대장은 장 정결제	혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약	진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지
빠스캔	주사 후 물 많이 마시기	임신·수유	주사 후 2~4시간 대기

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

항목	기록
담당 교수 / 진료과	
평일 진료실·외래 간호사실 ☎	

항목	기록
야간·휴일 연락처 ☎	
가까운 응급실(치료 병원 우선)	
항암·방사선 치료실 ☎	
보호자 1 / 보호자 2 ☎	
국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시)	☎ 1577-8899
암생존자통합지지센터(지역암센터)	☎ 1577-9740
응급 119 · 정신건강 위기 109	

W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

항목	기록
날짜 / 진료과 / 의사	
오늘 들은 진단·병기	✓ / ⏳ / ?
오늘 결정된 것	
다음 검사·날짜	
다음 진료 날짜	
새로 받은 약	
꼭 지켜야 할 주의사항	
다음에 물어볼 것	

W3. 7일 증상 일지

날 짜	체온 (최고)	통증 0~10	식사(평소의 %)	배변· 배뇨	잠	기분 0~10	메모·연락 여부

W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐
				☐
				☐
				☐

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은
수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

주	날짜	한 일(✔) / 남은 일(⌚)
1주	Day 0-7	
2주	Day 8-14	
3주	Day 15-21	
4주	Day 22-30	

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Gastric Cancer, Version 4.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 한자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 위암 정보, 한국 위암 진료 가이드라인(대한위암학회 등), 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **참고문헌:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터, 위암 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.